Anticoagulantes en la fibrilación auricular

Indicaciones, dosis, ajuste renal, contraindicaciones y reversión · Guía **ESC 2024**

Original: Dra. Claudia Abad (Urgencias)
Hospital de Campdevànol
Versión 2.0 revisada según ESC 2024 · noviembre 2026

1 ¿CUÁNDO ANTICOAGULAR? · ESCALA CHA_2DS_2-VA (ESC 2024)

Factor	Puntos	Factor	Puntos
C · Insuficiencia cardiaca o FEVI reducida	1	S_2 · Ictus, AIT o tromboembolismo previo	2
H · Hipertensión arterial	1	V · Enfermedad vascular (IAM, arteriopatía periférica, placa aórtica)	1
A_2 · Edad ≥ 75 años	2	A · Edad 65–74 años	1
D · Diabetes mellitus	1	Máximo 8 puntos.	

≥ 2 → anticoagulación recomendada · 1 → considerarla (decisión compartida) · 0 → no anticoagular. Igual en hombres y mujeres.

La ESC 2024 retiró el sexo femenino de la escala (CHA_2DS_2-VASc → CHA_2DS_2-VA): actúa como modificador del riesgo, no como factor independiente. La ACC/AHA 2023 sigue usando CHA_2DS_2-VASc (mujeres: anticoagular con ≥ 3). HAS-BLED sirve para corregir factores de sangrado, no para negar la anticoagulación.

APIXABÁN · anti-Xa

FA
5 mg/12 h VO

Antes de la cardioversión
Opcional: **10 mg VO dosis única** (5 mg si cumple criterios de reducción); **cardiovertir ≥ 2 h después** y seguir con 5 mg/12 h (EMANATE).

Reducción
2,5 mg/12 h si ≥ 2 de: edad ≥ 80 años · peso ≤ 60 kg · creatinina ≥ 1,5 mg/dl.

Función renal
FG 15–29: 2,5 mg/12 h (precaución).
FG < 15: evitar.

La pauta 10 mg/12 h × 7 días es de la trombosis venosa, **no de la FA**.

RIVAROXABÁN · anti-Xa

FA
20 mg/24 h VO con la cena

Antes de la cardioversión
20 mg VO con comida.

Función renal
FG 30–49: 15 mg/24 h.
FG 15–29: 15 mg/24 h (precaución).
FG < 15: evitar.

Tomar siempre con comida (mejora la absorción).

DABIGATRÁN · anti-IIa

FA
150 mg/12 h VO

Antes de la cardioversión
150 mg VO.

110 mg/12 h
Edad ≥ 80 años · tratamiento con verapamilo.
Valorar de forma individual (75–80 años, gastritis o reflujo, riesgo hemorrágico alto).

Función renal
FG 30–50: **150 mg/12 h**; 110 mg/12 h solo si el riesgo hemorrágico es alto.
FG < 30: **contraindicado**.

HEPARINA · HBPM

HNF IV
Bolo 60–80 UI/kg (máx. 5.000 UI) + perfusión 12–18 UI/kg/h. TTPa 1,5–2,5 veces el control (60–100 s); control a las 4–6 h.
Sin ajuste por FG; válida en diálisis.

Enoxaparina
1 mg/kg/12 h SC.
FG 15–29: **1 mg/kg/24 h**.
FG < 15: usar HNF IV.
Anti-Xa si peso extremo o FG bajo.

Pauta de HNF según el protocolo local: no hay una dosis específica de FA en las guías.

2 CONTRAINDICACIONES (todos los ACOD)

- Sangrado activo significativo; lesión con alto riesgo hemorrágico.
- Prótesis valvular mecánica o estenosis mitral moderada-grave → **solo acenocumarol/warfarina (INR 2–3)**.
- Embarazo y lactancia · hipersensibilidad · hepatopatía grave (Child-Pugh C).
- Dabigatrán: FG < 30 · apixabán y rivaroxabán: FG < 15.
- Otro anticoagulante a la vez; cirugía o procedimiento reciente de alto riesgo hemorrágico.

3 PRECAUCIONES

- **FG 15–30:** apixabán o rivaroxabán a dosis reducida; dabigatrán contraindicado; vigilar la acumulación de HBPM.
- **Ancianos:** dabigatrán 110 mg/12 h desde los 80 años; apixabán 2,5 mg/12 h solo con 2 de 3 criterios. El riesgo de caídas **no** contraindica por sí solo.
- **Interacciones:** inhibidores de P-gp/CYP3A4 (verapamilo, amiodarona, claritromicina, azoles) suben los niveles; inductores (rifampicina, fenitoína, carbamazepina) los bajan; AINE y antiagregantes aumentan el sangrado.

4 HEMORRAGIA GRAVE Y REVERSIÓN · suspender, comprimir, reponer volemia y transfundir según necesidad

Fármaco	Reversor	Dosis
Apixabán **Rivaroxabán**	**Andexanet alfa** (Ondexxya) Consultar disponibilidad con farmacia	**Dosis baja:** 400 mg IV en bolo + 4 mg/min durante 120 min (480 mg). Si apixabán ≤ 5 mg o rivaroxabán ≤ 10 mg, o última toma hace ≥ 8 h. **Dosis alta:** 800 mg IV en bolo + 8 mg/min durante 120 min (960 mg). Si apixabán > 5 mg o rivaroxabán > 10 mg (o dosis desconocida) tomados hace < 8 h o a hora desconocida.
Anti-Xa sin andexanet	**Complejo protrombínico** (4 factores)	**50 UI/kg IV** (EHRA 2018), si no hay andexanet o no puede esperarse.
Dabigatrán	**Idarucizumab** (Praxbind)	**5 g IV** (2 viales de 2,5 g, seguidos o con ≤ 15 min entre ellos).
HNF	**Protamina**	1 mg por cada 100 UI de HNF **administradas en las últimas 2–3 h**; máx. 50 mg; IV lenta.
Enoxaparina	**Protamina** (reversión parcial)	1 mg por cada mg de enoxaparina si se puso hace < 8 h; 0,5 mg por mg si hace > 8 h.
Todos	Medidas generales	Hemorragia leve: comprimir y suspender o retrasar la dosis. **Carbón activado** si la ingesta fue hace < 2–4 h (la ACC/AHA 2023 lo acepta hasta 6–8 h).

5 SITUACIONES FRECUENTES EN URGENCIAS

- **FA < 24 h, estable, sin anticoagulación:** dos opciones válidas (ESC 2024). **a)** ACOD en dosis única (apixabán 10 mg, o 5 mg si cumple criterios, y cardiovertir ≥ 2 h después; o rivaroxabán 20 mg) → cardiovertir → continuar ≥ 4 semanas. **b)** Esperar y ver hasta 48 h con control de frecuencia y anticoagulación; si no revierte, cardiovertir.
- **FA < 24 h con FG < 30:** HNF IV (bolo 60–80 UI/kg + 12–18 UI/kg/h) → cardiovertir → anticoagulación crónica: apixabán 2,5 mg/12 h o rivaroxabán 15 mg/24 h si FG 15–29; si FG < 15, valorar con nefrología.
- **FA > 24 h o duración desconocida, estable:** iniciar ACOD según FG (dosis de FA, sin carga) → ≥ 3 semanas → cardioversión electiva, o antes si una ETE descarta trombo.
- **Tras cualquier cardioversión:** anticoagulación ≥ 4 semanas (opcional solo si el inicio era seguro < 24 h y CHA_2DS_2-VA = 0); después, según CHA_2DS_2-VA.

Siglas: ACOD, anticoagulante oral de acción directa; FG, filtrado glomerular por Cockcroft-Gault (ml/min); HNF, heparina no fraccionada; HBPM, heparina de bajo peso molecular; ETE, ecocardiografía transesofágica; P-gp, glucoproteína P.

Fuentes: ESC 2024 de FA (PMID 39210723); EHRA 2018 de ACOD (PMID 29562325); EMANATE (PMID 29659797); ACC 2020 de hemorragia con anticoagulantes (PMID 32680646); ANNEXA-4 (PMID 36802876); ACC/AHA 2023 (PMID 38033089); fichas técnicas. Uso orientativo. **Pendiente de validación por la autora.**